03 O adolescente pediu ou já usa suplemento: conduta passo a passo

Versão impressa do fluxo interativo do kit, para deixar na mesa do consultório. Os seis passos valem para todos; cada um acrescenta o que for preciso ao plano.

1. Pergunte antes de opinar

O que toma ou quer tomar, para quê, quanto, onde compra e quem indicou; explore alimentação, treino, sono e imagem corporal (roteiro no item 06)[1].

2. Procure sinais que mudam a prioridade da consulta

Restrição, perda de peso ou alteração menstrual: avalie baixa disponibilidade de energia (item 10)[2].

Sofrimento com a aparência ou rotina rígida de treino e dieta: rastreie dismorfia muscular e encaminhe para saúde mental quando indicado[3].

3. Se já usa algum produto, conduza cada um

Creatina: combine a suspensão, sem bronca; não é autorizada em suplementos de 0 a 18 anos[4,5].

Proteína em pó: calcule a ingestão da dieta antes de decidir; jovens futebolistas, em média, já passam da meta com comida[8,9].

Energético ou pré-treino: desaconselhe e some a cafeína de todas as fontes; teto de 2,5 mg/kg/dia (item 11)[6,7].

Sem procedência ou com promessa hormonal: investigue esteroides; procure acne, ginecomastia e mudança rápida do corpo ou do humor[10,11].

4. Há indicação clínica?

Dieta restritiva que não alcança a meta, como em alguns vegetarianos[12], ou doença com indicação estabelecida, como a deficiência de guanidinoacetato metiltransferase[13]. Se sim, avaliação nutricional completa e acompanhamento[14].

5. Há comida suficiente em casa?

Pergunte. A insegurança alimentar pede rede de proteção social e alimentação escolar antes de qualquer produto[15]. Acione o serviço social da unidade e a escola.

6. Comida primeiro, em todos os casos, e retorno marcado

Proteína em cerca de 5 refeições, com 0,3 g/kg em cada uma e meta diária perto de 1,5 g/kg[9]; lanche pós-treino de comida (item 15); água durante o treino (item 02); sono de 8 a 10 horas de 13 a 18 anos[16]. Registre no prontuário (item 06) e, com a concordância do adolescente, inclua o treinador no plano (item 18)[17].

Material de apoio da aula “Creatina e Whey Protein: modismo inadequado”, 42º Congresso Brasileiro de Pediatria, Belo Horizonte, outubro de 2026. Getúlio Bernardo Morato Filho, Escola Superior de Ciências da Saúde, Brasília, DF. Uso educacional livre, com citação da fonte.

COMO USAR ESTE FLUXO

- Siga os passos em ordem; cada um acrescenta ao plano, nenhum encerra a consulta.
- Os sinais do passo 2 podem surgir em qualquer momento da conversa e, quando presentes, passam à frente do restante.
- Na versão interativa, o fluxo monta ao final um resumo pronto para o prontuário.

ITENS DO KIT CITADOS NO FLUXO

- 02 Água no treino
- 06 Roteiro de entrevista e modelo de registro
- 10 Deficiência energética relativa no esporte
- 11 Energéticos, cafeína e pré-treino
- 15 Cardápio de lanches pós-treino
- 18 Carta ao treinador e à escola

FONTES

1. Eisenberg ME, Wall M, Neumark-Sztainer D. Muscle-enhancing behaviors among adolescent girls and boys. Pediatrics. 2012;130(6):1019-26. doi:10.1542/peds.2012-0095
2. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, Burke LM, Constantini N, Hackney AC, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med. 2023;57(17):1073-97. doi:10.1136/bjsports-2023-106994
3. Nagata JM, Hur JO, Murakami K, Ganson KT, He J, Murray SB, et al. Muscle dysmorphia in adolescents and young adults. Lancet Child Adolesc Health. 2026;10(2):122-34. doi:10.1016/S2352-4642(25)00283-4
4. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2018 jul 27; Seção 1. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/int0028_26_07_2018.pdf
5. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 373, de 5 de junho de 2025. Altera a Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, que estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2025 jun 9; Seção 1.
6. Sociedade Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Nutrologia. Consumo de bebidas energéticas por crianças e adolescentes. Documento Científico nº 10. Rio de Janeiro: SBP; 2022 [citado 2026 out 12]. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/23377c-DC-Consumo_BebEnergeticas_crc_e_adl.pdf
7. Health Canada. Caffeine in foods [Internet]. Ottawa: Government of Canada; 2025 [citado 2026 out 11]. Disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/food-safety/food-additives/caffeine-foods.html
8. Steffl M, Kinkorova I, Kokstejn J, Petr M. Macronutrient intake in soccer players: a meta-analysis. Nutrients. 2019;11(6):1305. doi:10.3390/nu11061305
9. Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6
10. LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300
11. Nieschlag E, Vorona E. Mechanisms in endocrinology: medical consequences of doping with anabolic androgenic steroids: effects on reproductive functions. Eur J Endocrinol. 2015;173(2):R47-58. doi:10.1530/EJE-15-0080
12. Barretto JR, Gouveia MADC, Alves C. Use of dietary supplements by children and adolescents. J Pediatr (Rio J). 2024;100 Suppl 1:S31-9. doi:10.1016/j.jped.2023.09.008
13. Ream MA, Lam WKK, Grosse SD, Ojodu J, Jones E, Prosser LA, et al. Evidence and recommendation for guanidinoacetate methyltransferase deficiency newborn screening. Pediatrics. 2023;152(2):e2023062100. doi:10.1542/peds.2023-062100
14. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-55. doi:10.1136/bjsports-2018-099027
15. Hargreaves D, Mates E, Menon P, Alderman H, Devakumar D, Fawzi W, et al. Strategies and interventions for healthy adolescent growth, nutrition, and development. Lancet. 2022;399(10320):198-210. doi:10.1016/S0140-6736(21)01593-2
16. Paruthi S, Brooks LJ, D'Ambrosio C, Hall WA, Kotagal S, Lloyd RM, et al. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6):785-6. doi:10.5664/jcsm.5866
17. Elliot DL, Goldberg L, Moe EL, Defrancesco CA, Durham MB, Hix-Small H. Preventing substance use and disordered eating: initial outcomes of the ATHENA (athletes targeting healthy exercise and nutrition alternatives) program. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(11):1043-9. doi:10.1001/archpedi.158.11.1043